

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

KULAK BURUN BOĞAZ SERVİSİ OLGU SUNUMU

Hazırlayan: Hemşire Fatma ÇETİN
Hemşire Melek ÖZCAN

24.04.2026

OLGU SUNUMU

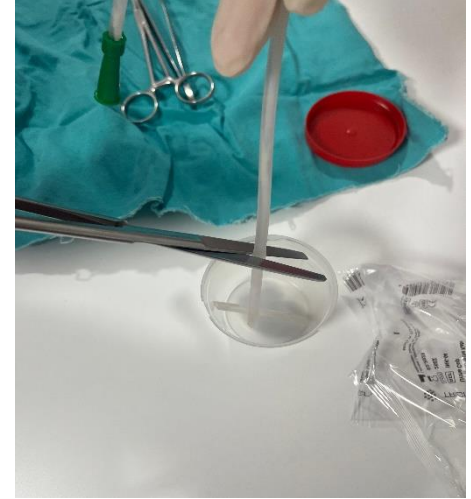
- 66 yaşında erkek hasta 7-8 ay önce alt damakta ağrı, yanma şikayeti ile diş doktoruna başvurmuş, yapılan muayene sonucu damakta lezyon fark edilmiş, KBB'ye yönlendirilen hastaya yapılan görüntüleme ve biyopsi işlemlerinin ardından Ağız-Dil Malign Neoplazm tanısı almış.

OPERASYON:Mandibular kitle eksizyonu+boyun diseksiyonu+trakeostomi açılması+flep çevrilmesi



Yara yeri enfeksiyonu ve faringokutonöz fistül komplikasyonu gelişen hastaya enfeksiyon takibi açısından;

- Trakeal aspirat kültürü
- Kan/idrar kültürü
- Crp wbc takibi
- Vital takibi
- Dren takibi
- Akciğer grafisi



Laboratuvar Sonuçları

	28/1/2026	03/02/2026	16/03/2026
CRP (<5)	60.85 mg/l	72.63 mg/l	91.9 mg/l
WBC (3.46-10.04)	8.95 x10 [^]	10.97 x10 [^]	9.40 x10 [^]
NEU (1.47-7.34)	6.13 x10 [^]	10.000 x10 [^]	7.78 x10 [^]
PROKALSİTONİN (0 -0,046)	0.127 ng/mL	0.150 ng/mL	0,170 ng/mL
ALBUMİN (39,7-49,4)	37.1 g/l	24.2 g/l	35.0 g/l
PLT (172-380)	299 x10 [^]	289 x10 [^]	399 x10 [^]

ANTİBİYOTİK SÜRECİ

PROFİLAKSİ	POSTOP 1.GÜN	POSTOP 11. GÜN	POSTOP 41. GÜN
Sulcid flk 2gr	Sulcid flk 4x2 gr	Merosid flk 3x2 gr	Merosid flk 3x2 gr
Polgyl %0.5 mediflex	Polgyl %0.5 mediflex 3x1	Flukopol 1x200 mg 1v inf.	Flukopol 1x200 mg 1v inf.
		Tekosit flk 1x400mg	Tekosit flk 1x400mg

KÜLTÜR SONUÇLARI

- **Trakeal Asparat Kültürü : (14/02/2026)**
- 10.000 cfu/ml citrobacter koseri,
- 100.000 cfu/ml Difteroid basil üredi.
- 06/03/2026 tarihinde alınan kültürde üreme olmadı.
- **Kan Kültürü: (06/03/2026)**
- Kültürde üreme olmadı.
- **Yara Kültürü: (15/03/2026)**
- Difteroid basil üredi (deri florası).

Hemşirelik girişimleri

Braden Risk skalası :16 olan hastanın basınç yarası oluşumunu önlemek için;

- Sık pozisyon değişimi sağladık,
- Hastayı mobilizasyona teşvik edildi,
- Havalı yatak kullanıma geçildi,
- Çarşafların gergin,temiz ve kuru olması sağlandı
- Yara bakım hemşiresine danışılarak medikal tedavisi yapıldı.

- **Enfeksiyon riskini** azaltmak amacıyla ziyaretçi kısıtlaması sağlandı.
- Trakeal aspirasyon aseptik tekniklere uygun olarak yapıldı.
- Enfeksiyon riski olan hastanın vital takip sıklığı (8x1-12x1) olarak arttırıldı.
- Vücut ve saç bakımı hastanın süturları sebebiyle günlük vücut temizleme köpüğüyle silme şeklinde yapıldı.
- Oral mukoz membran bütünlüğünü sağlamak için,ağız bakım seti ve ağız içi aspirasyon uygulandı.

İtaki II Düşme Riski Ölçeği :15 olan hastanın düşmesini önlemek için ;

- Yatak kilit kontrolü sağlandı,
- Yatak kenarlıkları kaldırıldı,
- Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi.
- Kurum içi veya kurum dışı hasta transferine sağlık çalışanı eşlik edildi.
- Hasta transferi sağlanırken sedye, tekerlekli sandalyenin emniyet kemerleri takıldı.

NRS PUANI:3 olan hastayı;

- Nutrisyon ekibiyle birlikte beslenme planı oluşturuldu,
- Fistülü olan hastanın enfeksiyon riskini azaltmak,doku onarımını arttırmak amacıyla NG tüp aracılığıyla enteral beslenmeye başlandı,
- Aspirasyon riskini önlemek açısından 30- 45 derece semifowler pozisyonunda beslenmesi sağlandı,
- Beslenme öncesi rezidüel kontrol yapılmalı ve her beslenme sonrası yıkandı,
- Hastanın beslenme ürünlerine karşı tolerasyonu takip edilip(diyare,konstipasyon,distansiyon vb.) hekime bilgi verildi.



THANK YOU

TEŞEKKÜR EDERİM..